

L'observation en psychiatrie

A. Identité :

Nom
Prénom
Age
Fratie
Origine
Demeurant à
Profession
Niveau de scolarité

B. Motif d'hospitalisation

C. Antécédents

- Personnels :

Médicaux
Chirurgicaux
Psychiatriques : hospitalisations antérieures et suivi
Habitudes toxiques : quantité et durée
Gyneco-obstétricaux
Juridiques

- Familiaux :

Médicaux
Chirurgicaux
Psychiatriques

D. Biographie

(Recueillie auprès de : malade, famille, autres accompagnateurs)

- Scolarité
- Puberté
- Vie sexuelle
- Vie professionnelle
- Personnalité du malade
- Fratie
- Relations avec les parents et les frères
- Vie sociale
- Capacité d'établir des liens durables
- Capacité de maintenir des relations stables
- Intelligence (test)
- Hygiène corporelle et vestimentaire
- Faculté d'adaptation aux changements de lieux (voyages)

E. Histoire de la maladie

- Début
- Facteurs déclenchants et favorisants
- Chronologie
- Évolution de l'état actuel

F. Examen psychiatrique

1. LA PRESENTATION

- Tenue : négligée, adaptée
- Mimique : expressive, inexpressive, adaptée, inadaptée,
- Contact : facile, difficile, réticence, superficiel, hyper syntone
- Comportement : agitations, impulsions, stupeur, catalepsie, tics.

2. TROUBLES DES CONDUITES INSTINCTUELLES

- Contrôle sphinctérien de la miction et de la défécation
- Sommeil : insomnie, somnolence diurne, hypersomnie, perturbation de
- L'activité onirique
- Conduites alimentaires : Restrictions alimentaires, Refus alimentaires, Excès alimentaires
- Comportement sexuel: dysfonction sexuelle, paraphilies,

3. TROUBLES DES CONDUITES SOCIALES

- Suicide, tentative de suicide, équivalents suicidaires
- Fugues
- Vols pathologiques
- Attentats aux mœurs
- Homicide
- Actes incendiaires
- Agressions

4. CONDUITES ADDICTIVES

- Trouble de l'usage d'une substance
- Trouble addictif
- Dépendance comportementale

5. TROUBLES DES FONCTIONS SUPERIEURES

- Troubles du Langage : Logorrhée, mutisme, bégaiement, Aphasies, paralogisme, néologisme
- Troubles de la mémoire : Déficit mnésique : amnésie de fixation, rétrograde, antéro-rétrograde, lacunaire.

- Troubles du fonctionnement de la pensée et du jugement :

- ⇒ Troubles du cours de la pensée : Tachypsychie ; bradypsychie, barrages idéiques, difffluence de la pensée
- ⇒ Troubles du contenu de la pensée : Idées obsédantes / délirantes / dépressives/ Phobies
- ⇒ Distorsion globale de la pensée : Autistique, Magique, Paralogique, Rationalisme morbide
- ⇒ Troubles du jugement : Facilitation du jugement, Carence du jugement, Distorsion du jugement

6. Troubles de la perception

- Hallucinations
- Psychosensorielles
- Psychiques
- Absence de subjectivité
- Absence de sensorialité
- Sd d'automatisme mental

7. Conscience du soi et de l'environnement

- Troubles de la vigilance
- Conscience, attention, orientation temporo-spatiale
- Hypo ou hyper vigilance
- Etats crépusculaires
- Etats seconds
- Dépersonnalisation
- Déréalisation

8. Trouble des affects

- Hyperémotivité
- Anxiété
- Inadéquation
- Dépressive
- Expansive
- Indifférente

G. Examen physique

- Constantes hémodynamiques++
- Cardiovasculaire++
- Pulmonaire
- Neurologique++

H. Bilan complémentaire

- ECG +++
- EEG (surtout sujet âgé)
- Ionogramme sanguin
- FNS
- Bilan thyroïdien
- Bilan hépatique
- Bilan rénal
- Bilan toxicologique

Ce bilan est standard à l'admission, il sera complété en fonction des signes d'appel.

I. Conclusion

Reprendre les informations pertinentes

J. Discussion diagnostique

K. Conduite à tenir

Tenir compte du malade décrit et ne pas établir une conduite stéréotypée

L. Évolution

Sur le plan comportemental ; cognitif ; affectif ; instinctuel et physique.

M. Surveillance

Constantes++ (pouls, FR, température) ; ECG++ ; état de conscience, transit et miction, alimentation, sommeil, imprégnation NL.

N. Pronostic

Tant que le malade présente une forme clinique de sa pathologie accessible au traitement ; tant qu'il a un bon insight avec une bonne adhérence thérapeutique et tant que le support socio-familial est de bonne qualité = on reste optimiste quant à l'évolution.